SEMINAR HASIL · SEKOLAH PASCASARJANA IPB

SHINING
Sehat Sebelum Hamil itu Penting

Pengembangan Media Edukasi Gizi Online SHINING bagi Calon Pengantin: Evaluasi Proses Implementasi dan Pola Penggunaan Media Sosial

Development of the SHINING Online Nutrition Education Media for Premarital Couples: Implementation Process Evaluation and Social Media Use Patterns

Marhamah[1], Hardinsyah[2], Cesilia Meti Dwiriani[3], Lilik Kustiyah[3], Irman Hermadi[4]

[1]Mahasiswa Program Doktor Ilmu Gizi, FKGiz IPB · [2]Ketua Komisi Pembimbing, Prodi Ilmu Gizi, FKGiz IPB · [3]Anggota Komisi Pembimbing, Prodi Ilmu Gizi, FKGiz IPB · [4]Anggota Komisi Pembimbing, Prodi Ilmu Komputer, FMIPA IPB

1 Pendahuluan

Masa **prakonsepsi** adalah periode kritis untuk memperbaiki gizi calon ayah dan ibu, tetapi sering diabaikan.

~50% orang dewasa Indonesia BB lebih/obesitas

44–77% catin berpengetahuan gizi kurang

72,8% penduduk mengakses internet (2024)

- Gen Z & milenial (usia menikah) dominan daring; **77,6%** memakai internet untuk medsos.
- Misinformasi gizi menyebar luas; hampir **separuh** unggahan gizi akun populer tidak akurat.
- Dalam **Health Belief Model (HBM)**, medsos adalah *cue to action* — efeknya bergantung pada informasi yang dibaca dan cara menilainya.
- Intervensi online rentan ***law of attrition***; laporan dari negara berpenghasilan menengah masih terbatas.

Tujuan

1. Mengevaluasi **proses implementasi** platform web SHINING: penyelesaian pengisian & mutu data.
2. Menganalisis **pola penggunaan medsos** catin dan hubungannya dengan pengetahuan gizi prakonsepsi, sikap berbasis HBM, dan IMT.

2 Metode

Desain *Cross-sectional* + evaluasi proses (tahap pengembangan, model ADDIE)

Lokasi Kota Binjai, Sumatera Utara · Juli–Oktober 2026

Subjek Catin 20–40 tahun, kelompok kontrol; rekrutmen via brosur QR & WhatsApp

Etik KEPK Poltekkes Kemenkes Medan No. 01.26.1986/KEPK/2025; persetujuan elektronik

Platform SHINING — sesi 1 (6 instrumen)

Aplikasi web satu halaman untuk HP: tanpa unduhan, tanpa akun; masuk dengan nama + nomor HP/WA; data otomatis ke Google Sheets.

1 Identitas + BB/TB	2 Tes pengetahuan 48 butir	3 Sikap HBM 24 butir (6 konstruk)
4 FFQ	5 IPAQ-SF	6 Kuesioner media sosial

Alur subjek

1.344 rekaman mentah › 198 catin memenuhi syarat › 77 selesai 6 instrumen › **74 dianalisis**

Variabel & analisis

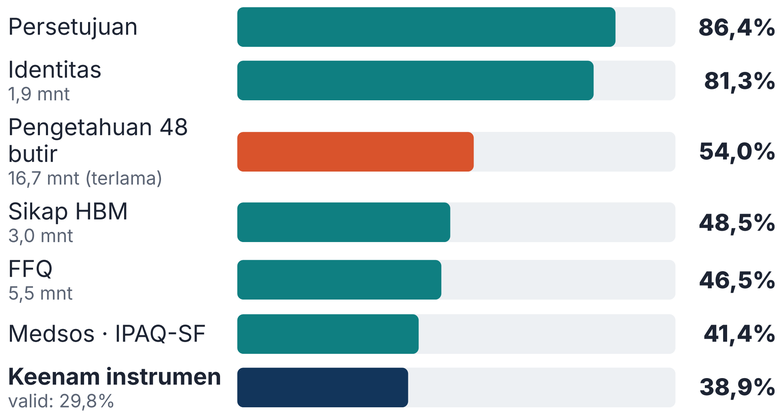
- Pengetahuan: baik >80%, sedang 60–80%, kurang <60%
- Sikap HBM: Likert 4 poin, skor 24–96; positif ≥72
- IMT (PNPK Obesitas 2025): BB lebih/obes ≥23,0 kg/m²
- Indikator proses: penyelesaian, lama isi, kiriman ganda, karantina, data hilang
- Spearman, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, χ^2/Fisher; dikontrol peran; p<0,05

Kerangka HBM (6 konstruk × 4 butir)

Kerentanan risiko gizi salah bagi diri & calon bayi	**Keparahan** dampak anemia, obesitas, stunting	**Manfaat** gizi baik sebelum hamil
Hambatan biaya, waktu, kebiasaan makan keluarga	**Isyarat bertindak** medsos, WhatsApp, edukasi SHINING	**Efikasi diri** yakin mampu makan sehat

3 Hasil: Kinerja Platform

Penyelesaian instrumen sesi 1 (n=198) · **merah** = penurunan terbesar



13,8% kiriman berulang (186/1.344); 68,3% dari halaman daftar/persetujuan yang terbuka ulang

26,9%→0% blok makanan pokok FFQ hilang; teratasi dengan simpan draf otomatis (p=0,04)

37→56% penyelesaian sesi 1 setelah perbaikan Okt (p=0,137; tidak bermakna)

4,4–4,7 skor kemudahan dari 15 mahasiswa (skala 5) — tidak mencerminkan kondisi lapangan

Perbaikan platform secara iteratif

- **Akhir Juli** · persetujuan tak tersimpan, angka 0 nomor HP hilang → skrip ulang: normalisasi nomor, lembar karantina, penanda duplikat, status selesai dikonfirmasi server
- **Agustus** · uji kemudahan 15 mahasiswa — tanpa masalah besar
- **Awal Oktober** · progres hilang saat ganti HP; isian kosong → progres dilacak per nomor; validasi; kirim ulang otomatis
- **Pertengahan Oktober** · blok FFQ hilang; tahap awal terlalu panjang → simpan draf otomatis; persetujuan berlapis; kartu "selamat datang kembali"
- **Akhir Oktober** · pendaftaran ditutup, data dikunci

Beban & urutan instrumen, bukan kemudahan antarmuka, yang paling menentukan keberlanjutan peserta. Uji sekali pakai oleh pengguna berpendidikan tinggi belum menggambarkan catin (mayoritas SMA, HP spesifikasi rendah, kembali berkali-kali).

4 Profil Media Sosial Catin

59,5% platform utama WhatsApp

73,0% akses hampir terus-menerus (± tiap jam)

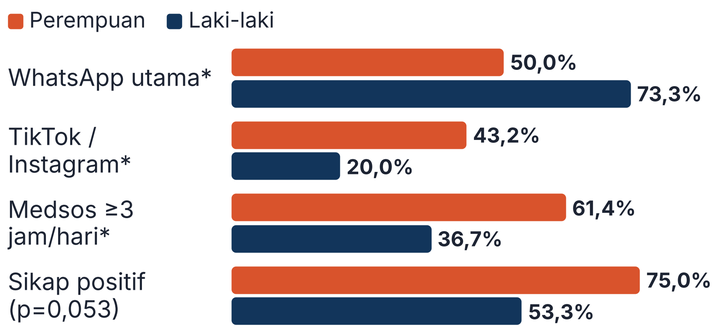
51,4% BB lebih / obesitas

75,7% info dari akun nakes / lembaga resmi

39,2% juga mengandalkan influencer

71,6% pernah tertarik produk yang dipromosikan

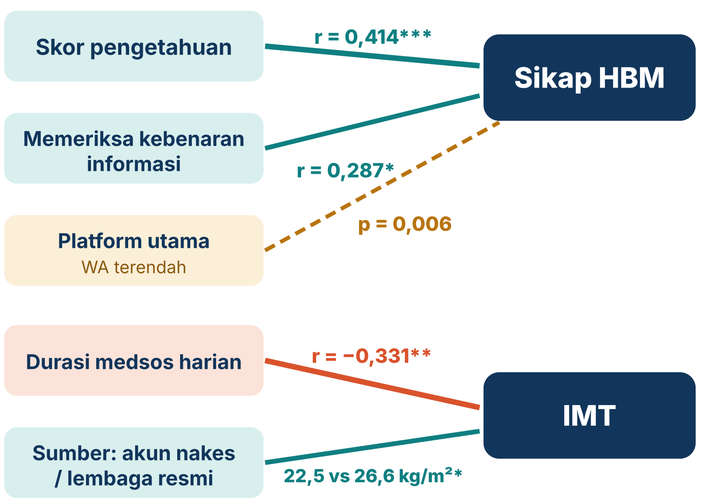
Perempuan (n=44) vs laki-laki (n=30)



*p<0,05 (uji khi-kuadrat/Fisher). Skor pengetahuan 84,3% vs 76,5% (p=0,150).

5 Hubungan Medsos, Pengetahuan, Sikap & IMT

Pengetahuan rerata **81,1 ± 16,8%**; **59,5%** berpengetahuan baik, namun >½ catin BB lebih/obes.



Garis = hubungan (bukan sebab-akibat). Spearman r_s; *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. Durasi–IMT tetap bermakna setelah dikontrol peran (r parsial −0,315; p=0,006). Frekuensi akses, pengetahuan, dan sikap **tidak** berhubungan dengan IMT.

Konstruk HBM

Persepsi hambatan terendah (68,5% skor maks.)	**Pengetahuan ↔ hambatan** r = 0,449***
Pengetahuan ↔ kerentanan r = 0,410***	**Pengetahuan ↔ efikasi diri** tidak berkorelasi

Cara memilih dan menilai informasi — bukan seberapa sering mengakses medsos — yang berhubungan dengan IMT lebih rendah dan sikap lebih positif.

6 Implikasi Desain Edukasi Online

1 Instrumen ringkas / dipecah ke beberapa kunjungan + simpan-lanjut	2 Pengingat terjadwal via WhatsApp untuk menekan angka berhenti
3 Penanda peserta & aturan kiriman ganda/HP bersama sejak awal	4 Penyimpanan dikonfirmasi server, dipantau tiap minggu
5 Laki-laki via WhatsApp; perempuan juga via konten singkat TikTok/IG	6 Perubahan platform didokumentasikan bertanggal (CONSORT-EHEALTH)

7 Simpulan & Saran

- Platform web sederhana layak untuk penelitian prakonsepsi online, tetapi **beban peserta, kiriman ganda, dan data hilang** perlu diantisipasi sejak perancangan.
- Penggunaan medsos catin intensif dan **didominasi WhatsApp**.
- Pengetahuan umumnya baik dan berkorelasi dengan sikap HBM, namun **>½ catin BB lebih/obes**.
- IMT lebih rendah & sikap lebih positif terkait **sumber kredibel dan verifikasi informasi**.

Saran

Edukasi gizi prakonsepsi online perlu membiasakan catin **memeriksa kebenaran informasi & izin edar produk**, merujuk sumber kredibel, serta memanfaatkan **WhatsApp untuk pengingat dan pendampingan**.

Pustaka utama: Janz & Becker 1984 Health Educ Q 11:1–47 · Carpenter 2010 Health Commun 25:661–669 · Eysenbach 2005 JMIR 7:e11 · Eysenbach 2011 JMIR 13:e126 · Meyerowitz-Katz et al. 2020 JMIR 22:e20283 · Musgrave et al. 2023 JMIR 25:e41900 · Denniss et al. 2024 IJBNPA 21:16 · Galesic & Bosnjak 2009 Public Opin Q 73:349–360 · Stephenson et al. 2018 Lancet 391:1830–1841 · Laurence et al. 2025 Front Digit Health 7:1542006 · Amiri et al. 2023 BMC Health Serv Res 23:1176 · BPS 2025.

Keterbatasan: sampel kecil, BB/TB dilaporkan sendiri, eksploratif tanpa regresi, desain potong lintang.

Terima kasih: para catin, mitra Pemda Kota Binjai, dan Universitas Terbuka (beasiswa doktor).